MÓDULO 10 · MEDICAL OMNICANAL Y LÍDERES DE OPINIÓN DIGITALES

Qué es el medical omnicanal

Omnicanalidad médica es el enfoque que sitúa al profesional sanitario en el centro de la estrategia de comunicación, integrando de forma coordinada todos los canales a través de los cuales Medical Affairs interactúa con él —visitas presenciales, correo electrónico, contenido científico digital, webinars, redes profesionales, congresos— de manera que cada punto de contacto conecta con el anterior en lugar de repetirlo, y la experiencia percibida por el HCP es la de una conversación científica continua, no la de mensajes desconectados llegando desde distintas direcciones de la misma organización.

OMNICANALIDAD MÉDICA

- HCP en el centro de la estrategia de comunicación
- Canales integrados y coordinados (visitas, email, digital, webinars, congresos)
- Cada contacto conecta con el anterior, no lo repite
- Experiencia percibida como una **conversación científica continua**

Este enfoque responde a un cambio real y bien documentado en el comportamiento de los profesionales sanitarios: cada vez consumen información científica de forma más fragmentada a lo largo del día, combinando de manera fluida canales presenciales y digitales según su disponibilidad de tiempo, su preferencia de formato y el momento concreto de su jornada clínica. Un HCP puede leer un resumen científico en su móvil entre dos consultas, participar en un webinar por la noche, y reservar la conversación en profundidad con un MSL para cuando la relación de confianza y la complejidad de la pregunta lo justifiquen.

- Los HCPs consumen información científica de forma fragmentada durante el día
- Combinan canales presenciales y digitales según su disponibilidad
- Ejemplo: resumen científico en el móvil, webinar nocturno, conversación con el MSL

Lo que distingue a la omnicanalidad de la simple multiplicación de canales —tratada con detalle en la siguiente lección— es la coordinación deliberada alrededor del HCP: los datos sobre sus intereses, sus interacciones previas y sus preferencias se comparten entre los distintos canales y equipos, de forma que el contenido, la secuencia y el formato de cada nuevo contacto se ajustan a lo que ya se sabe de ese profesional, en lugar de repetir el mismo mensaje genérico sea cual sea el canal utilizado.

QUÉ DISTINGUE A LA OMNICANALIDAD

- Coordinación deliberada alrededor del HCP, no solo más canales
- Datos sobre intereses e interacciones previas se comparten entre equipos
- Contenido y secuencia se ajustan a cada profesional, no un mensaje genérico

Construir una capacidad omnicanal real exige varios elementos que van más allá de simplemente añadir canales digitales a la actividad existente. Requiere una visión unificada del HCP, habitualmente sostenida por un sistema de CRM compartido entre las distintas funciones que interactúan con él, que registre no solo el contenido comercial sino también las interacciones científicas relevantes. Requiere procesos y gobernanza que integren la planificación de los distintos canales dentro de un mismo plan médico, como se introdujo en el Módulo 9, en lugar de que cada canal se planifique de forma aislada por equipos distintos. Y requiere, de forma crítica para Medical Affairs, mantener en todo momento la separación entre comunicación científica no promocional y comunicación comercial, incluso cuando ambas comparten infraestructura tecnológica o datos sobre el mismo profesional sanitario.

ELEMENTOS PARA CONSTRUIR OMNICANALIDAD REAL

- Visión unificada del HCP sostenida por un CRM compartido entre funciones
- Procesos y gobernanza que integren los canales dentro de un mismo plan médico
- Separación estricta entre comunicación científica no promocional y comercial

Para el MSL, la omnicanalidad no sustituye la relación personal que constituye el núcleo de su función: la enriquece, permitiéndole entender mejor, antes de cada interacción presencial, qué contenido ha consumido ya un HCP y qué preguntas concretas podría estar esperando resolver en la conversación directa, y permitiéndole recomendar después contenido digital que profundice o dé continuidad a lo discutido en la visita, cerrando así un ciclo coherente de intercambio científico.

- La omnicanalidad no sustituye la relación personal del MSL: la enriquece
- Permite saber qué contenido consumió ya el HCP antes de la visita
- Permite recomendar contenido digital después, cerrando el ciclo científico